

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1097

19 febrero de 2026

Presentado por el señor *Ríos Santiago*

Referido a la

LEY

Para añadir un inciso (EE) al Artículo 2.030 y enmendar el Artículo 2.050, a los fines de añadir los subincisos (l), (m) y (n) en el inciso D, de la Ley 194-2011, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”; para enmendar la Sección 1 del Artículo III y añadir un nuevo inciso (h), y reenumerar los subsiguientes, así como enmendar la Sección 6 del artículo VI y añadir un inciso (g) del subinciso (1) del inciso “Cubierta C” de la Ley 72-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; a los fines de incorporar la definición de biomarcadores y establecer la cubierta obligatoria de pruebas de biomarcadores en los planes de salud en Puerto Rico, incluyendo el Plan de Salud del Gobierno; disponer sobre su aplicabilidad, reglamentación, deber de orientación y vigencia; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad, existe un consenso creciente en la comunidad científica y médica sobre la necesidad de moverse a un sistema de salud basado en la medicina personalizada, en donde las decisiones clínicas se fundamenten en las características biológicas individuales de cada paciente, tales como genes, proteínas u otros indicadores moleculares. Este enfoque persigue mejorar la efectividad de los tratamientos, reducir intervenciones innecesarias y optimizar el uso de los recursos del sistema de salud.

Como parte esencial de este modelo, las pruebas de biomarcadores constituyen una herramienta indispensable para identificar las particularidades biológicas de una enfermedad o de un individuo y así lograr decisiones médicas más informadas. En este contexto, las pruebas moleculares de herencia permiten detectar predisposiciones genéticas incluso antes de que aparezcan los síntomas, facilitando estrategias de prevención y vigilancia temprana o determinar cómo un paciente metaboliza un medicamento específico, lo que posibilita ajustar las dosis o seleccionar el fármaco más adecuado. También ayudan a identificar qué pacientes tienen mayor probabilidad de beneficiarse de un tratamiento específico y cuáles no obtendrían un beneficio clínico significativo, evitando así terapias ineficaces, costosas o potencialmente perjudiciales.

Un ejemplo claro de la importancia de las pruebas de biomarcadores se manifiesta en el campo de la oncología, donde estas pruebas han transformado la manera de diagnosticar y tratar diversos tipos de cáncer. En pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, por ejemplo, la identificación de mutaciones en genes como EGFR, ALK o ROS1 permite seleccionar terapias dirigidas que han demostrado prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida. De igual forma, en el cáncer de seno, biomarcadores como HER2 y los receptores hormonales (ER/PR) orientan el uso de terapias específicas, como anticuerpos monoclonales o tratamientos hormonales, que resultan significativamente más efectivos que los esquemas tradicionales. Asimismo, en el cáncer colorrectal, la evaluación del gen KRAS determina si un paciente responderá a ciertos tratamientos biológicos, mientras que otros marcadores, como la carga mutacional tumoral, ayudan a identificar pacientes que podrían beneficiarse de inmunoterapias. Estos ejemplos evidencian cómo el análisis molecular del cáncer permite personalizar el tratamiento en función de las características únicas del tumor de cada paciente, aumentando la probabilidad de éxito terapéutico y evitando intervenciones innecesarias o ineficaces.

En el campo de la prevención, determinar el riesgo individual de enfermedad permite desarrollar estrategias de manejo del riesgo personalizadas, orientadas tanto a la

prevención como a la detección temprana. En los cánceres hereditarios, la identificación de predisposición asociadas a syndromes como Li-Fraumeni syndrome (TP53), Lynch (MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2) o Síndrome de cáncer hereditario de mama y ovario (BRCA1 y BRCA2) permite implementar estrategias personalizadas de vigilancia, prevención e intervención oportuna, reduciendo la morbimortalidad y mejorando significativamente el pronóstico. En el síndrome de Li-Fraumeni, el riesgo de cáncer inicia a edades muy tempranas. Los niños presentan alta probabilidad de desarrollar sarcomas, tumores cerebrales, carcinoma adrenocortical y leucemias. Por ello, se recomienda vigilancia intensiva desde la infancia, incluyendo resonancia magnética corporal total y estudios periódicos, con el fin de detectar tumores en etapas iniciales. Este enfoque no solo contribuye a salvar vidas, sino también a reducir los costos médicos asociados a tratamientos en etapas avanzadas.

Sin embargo, a pesar de su valor clínico y de su reconocimiento en guías médicas y literatura científica, el acceso a pruebas de biomarcadores continúa siendo limitado debido a la ausencia de una cobertura clara y uniforme por parte de los planes médicos. Esta realidad obstaculiza el desarrollo de un sistema de salud verdaderamente basado en la medicina de precisión y restringe la capacidad de los profesionales de la salud para ofrecer tratamientos ajustados a las necesidades individuales de los pacientes.

Esta carencia en la cobertura genera, desigualdades en el acceso a tratamientos efectivos, particularmente entre aquellos pacientes que dependen exclusivamente de su plan médico para recibir atención. Diversas organizaciones de salud han advertido que esta situación perpetúa disparidades en los resultados clínicos y limita el aprovechamiento pleno de los avances científicos disponibles.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad del sistema, la cobertura de pruebas de biomarcadores también representa un beneficio para los propios planes médicos, ya que permite evitar gastos asociados a tratamientos inadecuados, hospitalizaciones prevenibles y el manejo de complicaciones derivadas de terapias que no resultan efectivas

para determinados pacientes. La inversión en diagnósticos precisos contribuye, por tanto, a un uso más eficiente de los recursos públicos y privados destinados a la salud.¹²

Este enfoque ya ha sido reconocido en distintas jurisdicciones de Estados Unidos, donde varios estados, como Nueva York, California y Rhode Island, han aprobado legislación que garantiza la cobertura de pruebas de biomarcadores. Estas iniciativas responden precisamente a criterios de eficiencia, costo-efectividad y mejor utilización de los recursos del sistema de salud, alineándose con los principios de sostenibilidad y calidad en la atención médica.

En consecuencia, resulta necesario y prudente adoptar medidas dirigidas a fomentar la implantación de un sistema de salud basado en la medicina personalizada, mediante la garantía de cobertura para pruebas de biomarcadores clínicamente validadas. Atender esta brecha solamente fortalece la calidad de la atención médica, sino que promueve la equidad en el acceso a los servicios de salud y asegura que las decisiones clínicas se fundamenten en evidencia científica, en beneficio de los pacientes, los proveedores de servicios de salud y el propio sistema sanitario.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Se añade un nuevo inciso (EE) al Artículo 2.030 de la Ley 194 de 2011,
2 según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico” para
3 que lea como sigue:

4 “Artículo 2.030. — Definiciones.

¹ Brito, R. A. (s/f). Total cost of lung cancer care associated with broad panel versus narrow panel sequencing. *Journal of Clinical Oncology*, 38. https://doi.org/10.1200/JCO.2020.38.15_suppl.7077.

² Yu, T. M., Morrison, C., Gold, E. J., Tradonsky, A., & Arnold, R. J. G. (2018). Budget impact of next-generation sequencing for molecular assessment of advanced non-small cell lung cancer. *Value in Health: The Journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research*, 21(11), 1278–1285. <https://doi.org/10.1016/j.jval.2018.04.1372>

1 Para fines de este Código y excepto para aquellos Capítulos donde se provea una
2 definición más específica, los siguientes términos tendrán el significado que se indica
3 a continuación:

4 **A.** “Beneficios cubiertos” o “beneficios” significa los servicios de cuidado de
5 la salud a los que una persona cubierta o asegurado tiene derecho conforme
6 a un plan médico.

7 **B.** ...

8 ...

9 *EE. Biomarcadores: Cualquier análisis de biomarcadores moleculares, genéticos*
10 *(heredado o adquiridos), proteicos, metabolitos u otros indicadores biológicos validados*
11 *clínicamente, utilizados para detectar, diagnosticar, determinar pronóstico, estratificar*
12 *riesgo, guiar la selección de terapias dirigidas, monitorear respuesta al tratamiento, o*
13 *evaluar recurrencia de enfermedades, incluyendo, pero sin limitarse a análisis de genes,*
14 *proteínas, cromosomas o metabolitos identificados en tejido, sangre u otros*
15 *especímenes biológicos, cuando estén sustentadas por evidencia médica y científica*
16 *aceptada."*

17 Artículo 2.- Se enmienda el Artículo 2.050 de la Ley 194 de 2011, según enmendada,
18 conocida como “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, y añadir nuevos
19 subincisos (l,m,n) en el inciso D.

20 “Artículo 2.050 — Conformidad con Leyes Federales. (26 L.P.R.A. § 9005)

1 Cualquier disposición de este Código que conflija con alguna ley o reglamento
2 federal aplicable a Puerto Rico en el área de la salud o de los planes médicos, se
3 entenderá enmendada para que armonice con tal ley o reglamento federal. Además:

4 **A.** Ningún asegurador u organización de seguros de salud que provea planes
5 médicos grupales o individuales establecerá lo siguiente:

6 **(1)** Límites de por vida en los beneficios esenciales cubiertos, a tenor con la Ley
7 Pública 111-148, conocida como “Patient Protection and Affordable Care Act”, la Ley
8 Pública 111-152, conocida como “Health Care and Education Reconciliation Act” y los
9 reglamentos promulgados al amparo de éstas.

10 **(2)** ...

11 **B....**

12 ...

13 **D.** Todo asegurador u organización de seguros de salud que provea planes
14 médicos individuales o grupales, con excepción de los planes médicos
15 “grandfathered” y de planes médicos de grupos grandes de empleados o grupos
16 grandes de una asociación bona fide, deberá asegurarse que todas sus cubiertas
17 incluyan el Conjunto de Beneficios de Salud Esenciales o “Essential health benefits
18 package” requerido a tenor con la Sección 1302(a) del “Patient Protection and
19 Affordable Care Act” y este inciso. El Conjunto de Beneficios de Salud Esenciales
20 constituye un plan médico que incluya:

21 **(1)** Los siguientes beneficios

22 a) Servicios ambulatorios, médico-quirúrgicos

1 b) ...

2 ...

3 *l) Pruebas de biomarcadores*

4 *m) Intención de no exclusión – Sin exclusiones basadas en la edad*

5 *n) Diagnóstico, predicción y pronóstico*

6 ..."

7 Artículo 3.- Se enmienda la Sección 1 del Artículo III de la Ley 72-1993, según
8 enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto
9 Rico", y añadir un nuevo inciso (h) y reenumerar desde la (i) hasta la (ii) para que lea
10 como sigue:

11 "Sección 1. — Término y Frases (24 L.P.R.A. § 7002)

12 Para fines de esta ley, los siguientes términos y frases tendrán el significado que se
13 expone a continuación:

14 (a) **Administración:** Administración de Seguros de Salud de Puerto
15 Rico.

16 (b) ...

17 ...

18 (h) **Biomarcadores:** *Cualquier análisis de biomarcadores moleculares,*
19 *genéticos(heredado o adquirido), proteicos, metabolitos u otros indicadores biológicos*
20 *validados clínicamente, utilizados para detectar, diagnosticar, determinar pronóstico,*
21 *estratificar riesgo, guiar la selección de terapias dirigidas, monitorear respuesta al*
22 *tratamiento, o evaluar recurrencia de enfermedades, incluyendo, pero sin limitarse a*

1 *análisis de genes, proteínas, cromosomas o metabolitos identificados en tejido, sangre u*
 2 *otros especímenes biológicos, cuando estén sustentadas por evidencia médica y científica*
 3 *aceptada."*
 4 *..."*

5 Artículo 4.- Se añade un nuevo inciso (g) del subinciso (1) del inciso "Cubierta C"
 6 de la Sección 6 del Artículo VI de la Ley 72-1993 ,según enmendada, conocida como
 7 "Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico", para que lea como
 8 sigue:

9 " Sección 6. — Cubierta y Beneficios Mínimos. (24 L.P.R.A. § 7032)

10 Los planes de salud tendrán una cubierta amplia, con un mínimo de exclusiones.
 11 No habrá exclusiones por condiciones preexistentes, como tampoco períodos de
 12 espera, al momento de otorgarse la cubierta al beneficiario.

13 ...

14 **Cubierta C.** En su cubierta ambulatoria los planes deberán incluir, sin que esto
 15 constituya una limitación, lo siguiente:

16 (1) Servicios de Salud Preventivos:

17 (a) Vacunación de niños y adolescentes hasta los dieciocho (18) años de
 18 edad.

19 (b) ...

20 ...

21 (g) *Las pruebas de biomarcadores realizadas con fines de diagnóstico,*
 22 *tratamiento, manejo adecuado o monitoreo continuo de la enfermedad o condición de una*

1 *persona cubierta, cuando la prueba ofrece utilidad clínica para el paciente según lo demostrado*
2 *por evidencia médica y científica.*

3 ...”

4 Artículo 5.- Aplicabilidad

5 Esta Ley aplicará a todos los contratos y pólizas emitidos, enmendados o
6 renovados luego de su vigencia por entidades sujetas al Código de Seguros de Puerto
7 Rico. La ASES garantizará la implementación de estas disposiciones en el Plan de
8 Salud del Gobierno.

9 Para planes autoasegurados sujetos a prelación federal (ERISA) u otros esquemas
10 exentos, se promoverá su adopción voluntaria. Nada de lo dispuesto en esta Ley se
11 interpretará como una contravención a las leyes federales aplicables

12 Artículo 6.- Reglamentación.

13 Se ordena a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), Departamento de
14 Salud, Administración de Seguros de Salud (ASES) para el Plan de Salud del Gobierno
15 y a la Oficina del Procurador del Paciente a modificar los reglamentos vigentes y cartas
16 normativas en un término no mayor de ciento ochenta (180) días desde la vigencia de
17 esta Ley para su implementación uniforme, incluyendo estándares de facturación.

18 Artículo 7.- Deber de orientación

19 Será responsabilidad de la OCS y de la ASES brindar orientación e información
20 a las aseguradoras, entidades de seguros de salud y terceros administradores respecto
21 al alcance y las disposiciones de las enmiendas introducidas por esta Ley. Asimismo,
22 el Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina del Procurador del Paciente,

1 tendrá el deber de elaborar e incorporar en sus programas educativos y materiales de
2 divulgación dirigidos a pacientes, profesionales de la salud y al público en general,
3 contenido informativo sobre las pruebas de biomarcadores, las alternativas de
4 cernimiento existentes y las opciones disponibles para acceder a cobertura.

5 Artículo 8.- Vigencia

6 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.